내 LDL 목표는 왜 남과 다를까요

"검진에서 정상"과 **"내 치료 목표"**는 다릅니다. LDL 목표는 내 혈관의 위험도에 따라 정해지고, **일찍 시작해 꾸준히** 낮출수록 혈관에 쌓이는 부담이 줄어듭니다.

목표는 위험도에 따라 다릅니다

나의 상황	LDL 목표
저위험 (위험인자 0~1개)	**160** mg/dL 미만
위험인자 2개 이상	**130** mg/dL 미만
당뇨 (10년 미만 · 위험인자·합병증 없음)	**100** mg/dL 미만
당뇨 (10년 이상, 또는 위험인자·합병증 중 하나라도)	**70** mg/dL 미만
경동맥 플라크* · 뇌졸중(뇌경색) 과거력* · 일과성 허혈발작(TIA)*	**70** mg/dL 미만
스텐트 · 심근경색 (+ 치료 전보다 50% 이상 감소)	**55** mg/dL 미만

※ **2026 지침 선택 목표:** 재발 위험이 높은 뇌경색, 합병증이 있거나 위험인자가 3개 이상인 당뇨는 **55 미만**까지 낮추기도 합니다.

검진 '정상' ≠ 내 목표 · NOTE

검진표의 **'정상'**으로 보이는 수치도 **내 치료 목표보다는 높을 수 있습니다.** 위험이 높을수록 목표를 더 낮게 잡습니다.

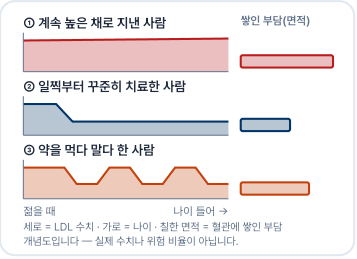
* 경동맥 플라크는 좁아진 정도와 전체 위험도를, 뇌경색·TIA는 원인(동맥경화 동반 여부)을 확인해 목표를 정합니다. 스텐트·심근경색은 55 미만과 함께 치료 전보다 LDL을 50% 이상 낮추는 것을 목표로 하며, 해당 고위험군에서도 50% 이상 감소를 함께 봅니다.

LDL은 간의 콜레스테롤 생성·처리 능력(유전적 요인)이 크게 좌우합니다

	LDL (나쁜 콜레스테롤)	중성지방
주로 정하는 것	음식보다 **간의 생성·처리 능력**	식사 · 술 · 체중
식사요법	모두에게 **기본 치료** — 다만 식사만으로는 목표에 못 미치는 경우가 많습니다	생활습관에 잘 반응합니다

식사요법(포화지방 줄이기)은 모두에게 **기본 치료**이고 **약과 함께 계속**합니다. 다만 LDL은 **간의 생성·처리 능력(유전 영향)**이 커서 식사만으로는 목표에 못 미치는 경우가 많습니다 — 이때 **약이 필요합니다.**

일찍, 꾸준히 — 위험은 '누적 노출'이 정합니다




오래 높을수록 혈관벽에 쌓입니다

2026 미국심장학회(ACC/AHA) 가이드라인의 메시지 — **"일찍 시작할수록 좋다"**

위험은 **LDL 곡선 아래 면적(누적 노출)**이 정합니다. 얼마나 높았는지 × 얼마나 오래였는지입니다.

일찍 시작할수록 그 이득이 오래 이어질 수 있습니다(레거시 효과).

약을 끊으면?

"나빠지는" 게 아니라 다시 올라갈 뿐입니다.
안경을 벗으면 다시 흐려지는 것과 같습니다.

좋아진 수치는 약이 일하는 중이라는 뜻입니다. 끊으면 올라간 기간만큼 **누적 노출이 다시 쌓입니다.**

커피와 식단도 LDL을 움직입니다

아메리카노 · 라떼

에스프레소처럼 종이필터를 거치지 않은 커피에는 **LDL을 올리는 기름 성분(카페스톨)**이 남아 있습니다.

믹스커피 · 종이필터 드립

LDL 면에서는 **괜찮습니다.**

저탄고지

LDL에는 **가장 나쁜 식단**입니다.

흔한 오해 vs 사실

자주 듣는 오해 · MYTH	바로잡기 · FACT
"콜레스테롤은 몸에 꼭 필요하니 너무 낮추면 안 된다"	몸에 필요한 콜레스테롤은 **세포가 스스로 만듭니다.**
"러닝하면 고기 먹어도 된다"	운동으로 LDL은 크게 안 내려갑니다. **포화지방은 여전히 LDL을 올립니다.**
"오메가3로 LDL을 잡는다"	오메가3는 중성지방을 일부 낮추고 항염증 효과가 있지만, **LDL을 낮추지는 못합니다.**

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2026 · 2026 ACC/AHA/Multisociety Dyslipidemia Guideline · EAS Consensus (Eur Heart J 2017) · LDL 누적 노출 (JACC 2020 · Nat Rev Cardiol 2024) · 커피 디테르펜 (Nutr J 2011) · 저탄고지 (Nutrients 2021)

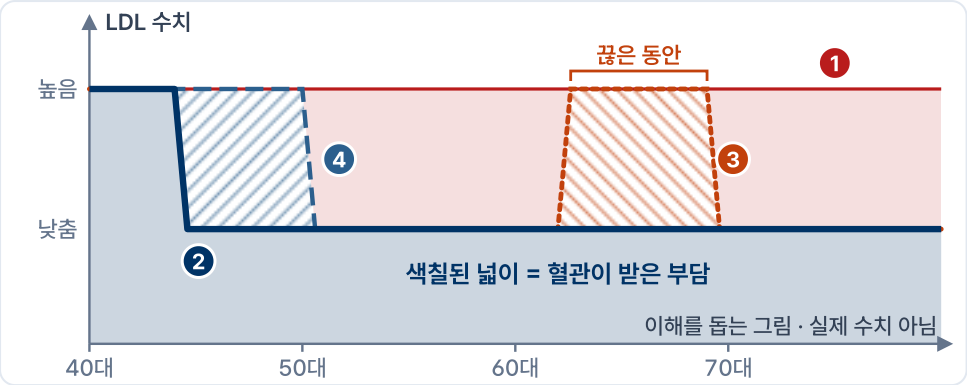
본 자료는 일반 안내입니다. 개인별 LDL 목표와 약 조정은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

뒷면 → 왜 일찍 시작하고, 왜 계속 먹을까요 (심근경색·뇌경색을 겪은 분이 혼자 끊으면 안 되는 이유 포함)

왜 일찍 시작하고, 왜 계속 먹을까요

LDL이 **높았던 기간이 길수록** 혈관에 더 쌓입니다 — 그래서 **일찍 시작하고 끊지 않는 것**이 핵심입니다.

색칠된 넓이 = 혈관이 받은 LDL 부담 (앞면 누적 그림 확대)



1. **계속 높음 — 가장 많이**
2. **일찍 시작 — 가장 적게**
3. **끊었다 다시 — 빗금만큼 더**
4. **늦게 시작 — 빗금만큼 더**

건강한 성인 26년 추적 연구: LDL 160~189의 위험은 처음 10년엔 잘 안 보이다가 **오래 지나 뚜렷해졌습니다.**

왜 일찍 — 먼저 시작한 이득은 오래 남을 수 있습니다(레거시 효과)



뒤: 늦게 시작한 사람 앞: 일찍 시작한 사람

원장님 설명 "5년 일찍 드신 분이 그 5년만 좋을 줄 알았는데, 늦게 시작한 분은 나중에 약을 써도 그 차이가 오래 남더라고요."

- 약을 **5년쯤** 먹은 사람들을 **20년** 지켜보니, 가짜약을 먹은 쪽보다 심장·혈관 병 사망이 **21% 적었습니다**(심장병이 없던 45~64세 남성, LDL이 높았음).
- 심장·혈관 병이 있던 분들은 추가 약(주사)을 **처음부터** 쓴 쪽이 2년쯤 늦게 쓴 쪽보다 심근경색·뇌졸중 같은 큰 병이 적었습니다.

약이 필요하다고 들었다면, 오늘이 쌓이는 양을 줄일 가장 빠른 날입니다.

왜 계속 — 혈압약·당뇨약과 다른 점

비교	혈압약 · 당뇨약	콜레스테롤 약(스타틴)
많이 내려가면?	너무 낮아지면(저혈압·저혈당) **의사가 약을 줄이거나 바꿉니다.**	LDL은 **낮을수록 위험이 더 낮습니다.** 위험이 높은 분들의 큰 연구에서 많이 낮춰도 특별한 안전 문제는 없었습니다.
좋아지면 끊나요?	의사가 보고 조절 — **혼자 끊지 않습니다.**	**아니요.** 좋아진 수치는 약이 일하는 중이라는 뜻입니다. 끊으면 LDL이 다시 올라, 2~3개월이 지나면 **약 먹기 전 수준으로 돌아갑니다**(그래프 ③).

주의 **심근경색·뇌경색을 겪은 지 얼마 안 됐다면 끊으면 결과가 나쁘다는 보고가 있습니다 — 끊기 전에 꼭 상의하세요.**

망설여진다면 — 적은 양부터 시작할 수 있습니다

1 시작	2 검사 · 4~12주 뒤	3 계속	이럴 땐 바로
위험도를 보고 **적은 양(저용량)부터** 시작할 수 있습니다.	피검사로 **목표 도달·간 수치** 확인. 못 미치면 용량을 올리거나 약을 더합니다.	괜찮으면 계속, **3~12개월마다** 피검사.	**심한 근육통·힘 빠짐, 콜라색 소변, 눈·피부가 노래짐, 이유 없는 심한 피로** → 약을 멈추고 바로 진료(진료시간 밖이면 응급실).

가벼운 뻐근함엔 혼자 끊지 말고 알려 주세요(약을 바꿀 수 있음). **심근경색·스텐트·뇌경색이 있었다면 처음부터 센 약이 필요할 수 있습니다.** 임신 계획·임신·수유 중이면 미리 알려 주세요(임신이 확인되면 중단).

함께 보기 — 스타틴 오해와 사실·부작용 대처: edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/statin-myths-facts/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560 · 평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 이상지질혈증 진료지침 2026(한국지질·동맥경화학회: ACC/AHA 2026 요약·FOURIER-OLE·Cooper Center) · WOSCOPS 20년(Circulation 2016) · CARDIA (JACC 2020) · Ference (JACC 2012) · MedlinePlus

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/ldl-target-by-risk/